ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
«ԷՐԵԲՈՒՆԻ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ
Բաժանմունք / Ծառայություն՝ **Ամբուլատոր-խորհրդատվական / Նյարդաբանական ծառայություն**
Հասցե՝ **ՀՀ, ք. Երևան, 0087, Տիտոգրադյան փող. 14** | Հեռ.՝ **(+374 10) 47-11-00**

ԱՐՄԵԴ էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ
ՀՀ առողջապահության նախարարի ստանդարտացված էլ. ձևաչափ
Ամբուլատոր այցի քարտ / Էպիկրիզ

Բուժհաստատություն, Վերահսկողական, Վճարովի (Հիվանդի միջոցներով), Անձնական ներկայություն, Ամբուլատոր այց

Դեպքի № **418/07**

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԱՅՑԻ ԷՊԻԿՐԻԶ / ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

(Նյարդաբանի խորհրդատվական եզրակացություն)

Ելից թիվ՝ **ԱՊ-23/07-418** | Այցի սկիզբ՝ **06/07/2023 13:40** | Այցի ավարտ՝ **06/07/2023 14:15**

Դեպքի տեսակը՝ **Ամբուլատոր** | Դիմելու նպատակը՝ **Հիվանդության պատճառով (Սրացում)** | Ֆինանսական աղբյուր՝ **Վճարովի**

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ / ՊԱՑԻԵՆՏԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Անուն, հայրանուն, ազգանուն՝ **ՍԵՎԱԿ ՍԱՄՎԵԼԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ** | Ծննդյան ամսաթիվ՝ **17/03/1987** (Սեռ՝ **Արական**)

ՀԾՀ՝ **2717038704** | Անձնագիր / ՆՔ՝ **AL0473417** | RAP ID / UID՝ **3703870421**

Բնակության վայրը (հասցե)՝ **ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Դալար, Գ. Նժդեհի փող., տուն 50**

Սոցիալական կարգավիճակ / խումբ՝ **Որևէ սոց. խմբի չպատկանող անձինք**

ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ / ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ (ՀՄԴ-10)

Հիմնական ախտորոշում (Վերջնական)՝

F43.1 — Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարում (ՀՏՍԽ)՝ ծանր աստիճանի, սրացման փուլում **06/07/2023 13:45**

Ուղեկցող ախտորոշում (Վերջնական)՝

G90.8 — Վեգետատիվ-անոթային դիստոնիա (ՎԱԴ)՝ հաճախակի պարոքսիզմներով **06/07/2023 13:45**

ՋՆՆՈՒՄ ԵՎ ՕՐԱԳԻՐ (ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ)

Գանգատներ և անամնեզ՝

Պացիենտը գտնվում է ամբուլատոր հսկողության տակ 2022 թ. մայիսից՝ հարազատի ողբերգական մահվան հետևանքով զարգացած ծանր հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման (ՀՏՍԽ) և վեգետատիվ-անոթային դիստոնիայի կապակցությամբ: Ներկայումս դիմել է կրկնակի՝ նյարդահոգեբանական վիճակի կտրուկ սրացմամբ, որը, ըստ պացիենտի խոսքերի, պայմանավորված է 29.06.2023 թ. իր նկատմամբ կիրառված ֆիզիկական բռնությամբ և սպառնալիքներով: Գանգատվում է կայուն անքնությունից, հաճախակի խուճապային գրոհներից և ուշագնացություններից (նախաուշագնացային վիճակներից)՝ ուղեկցվող շնչահեղձությամբ, սառը քրտինքով, մարմնի անկառավարելի դողով և սուր տագնապով:

Օբյեկտիվ զննում՝

Գիտակցությունը՝ պարզ: Դեմքի (աջ ակնակապիճային շրջանում, շրթունքի) և կողոսկրերի շրջանում առկա են հետտրավմատիկ արյունազեղումներ (հեմատոմաներ): Օջախային նյարդաբանական ախտաբանություն չի հայտնաբերվել: Առկա է արտահայտված վեգետատիվ լաբիլություն, ձեռքերի մատների տրեմոր, էմոցիոնալ լարվածություն: ԶՃ՝ 140/90 մմ ս.ս., պուլս՝ 98 զ/ր:

ԸՆԴՈՒՆՎՈՂ ԴԵՂՈՐԱՅՔ (ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԴԵՂԱՏՈՄՍ)

Դեղատոմսի համար՝	**02307064 / 4182**	Դեղաչափ՝	**10 Միլիգրամ**
Վճարման տեսակ՝	**Հիվանդի միջոցներով**	Քանակ՝	**1**
Համընդհանուր անվանում՝	**բուսպիրոն (buspirone)**	Անգամ՝	**2 (1 օրում)**
Բրենդային անուն՝	**Սպիտոմին (Spitomin)**	Ժամանակահատված՝	**30 օրում**
Ընդունման եղանակ՝	**ներքին ընդունման (per os)**	Ընդամենը՝	**60**
Դեղաձև՝	**դեղահատեր**		

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԳՐԱՌՈՒՄ / ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

1. Շարունակել **Սպիտոմին (Spitomin) 10 մգ** դեղամիջոցի ընդունումը՝ 1 հաբից օրական 2 անգամ, հոգեթերապևտի ամբուլատոր հսկողություն:

2. Հոգետրավմատիկ իրավիճակից և սթրեսային գործոններից լիակատար մեկուսացում: Նյարդային համակարգի հետագա հյուծումը կանխելու նպատակով ցուցված է սովորական միջավայրի ժամանակավոր փոփոխություն, առողջարանային ռեժիմ և կլիմայաբուժություն (նախընտրելի է մեղմ ծովային կլիմայական գոտում):

Բուժող բժիշկ (Նյարդաբան)՝ **Զ. Վ. Խեչումյան** | Ամսաթիվ՝ **06/07/2023** թ.

Փաստաթուղթը ձևավորվել է «ԱՐՄԵԴ» էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում
Արտահանման ամսաթիվ՝ **06/07/2023 14:30** (Պացիենտի անձնական էջից)
Նույնականացման կոդ (ID)՝ **9FA4C73187031746E20230706AB814D952C7418E63F0128B**